



Rapport de recherche “Espoir”



Référence : ES-01

Auteur : Silas Bosco

Sujet : Individu vivant en environnement saturé au NX-A depuis plusieurs années

Statut : Vivant / état compensé instable

RAPPORT MÉDICAL ET GÉNÉTIQUE COMPLET – SUJET EXPO NX-A

I. CONTEXTE

Le sujet évolue depuis une période prolongée en zone fortement contaminée par le gaz NX-A. Il aurait également subi diverses expérimentations hostiles non documentées. Malgré une exposition théoriquement létale pour un sujet standard, l'individu demeure vivant et fonctionnel, au prix d'une dégradation physiologique avancée.

Un prélèvement sanguin a été effectué afin d'établir un profil génétique, métabolique et clinique complet, dans l'objectif d'évaluer ses chances de survie et les possibilités thérapeutiques.

II. MÉTHODOLOGIE

- Prélèvement sanguin veineux : 10 mL/30mL sur tube EDTA.
- Extraction d'ADN leucocytaire par purification standardisée.
- Contrôle d'intégrité génomique et quantification.
- Séquençage haut débit (NGS) ciblé sur gènes impliqués dans la neuroprotection, la détoxification et l'adaptation respiratoire.
- Spectrométrie de masse plasma/cellules.
- Analyse protéomique partielle.
- Recherche de mutations acquises, méthylation anormale et remaniements somatiques.
- Croisement des données via bases ToxiGene v3.2, MutAdapt Atlas et base interne Bosco NX-A.



RAPPORT MÉDICAL ET GÉNÉTIQUE COMPLET – SUJET EXPO NX-A

III. GÈNES ANALYSÉS

Gène	Fonction supposée	Localisation
NXR1	Réponse aux neurotoxiques	Chromosome 2q31
CHAE	Régulation cholinergique adaptative	Chromosome 7q22
CYPNX4	Métabolisme toxique hépatique	Chromosome 19p13
GST-XM1	Détoxification secondaire	Chromosome 1p13
HMOX2	Protection oxydative	Chromosome 16p13
EPAS1	Adaptation hypoxique	Chromosome 2p21



RAPPORT MÉDICAL ET GÉNÉTIQUE COMPLET – SUJET EXPO NX-A

IV. RÉSULTATS GÉNÉTIQUES

Gène	Variant détecté	Génotype	Statut
NXR1	c.908A>G (p.Tyr303Cys)	Homozygote	R+
CHAE	c.1615C>T (p.Arg539Trp)	Hétérozygote	R
CYPNX4	*3/*7	Métaboliseur atypique lent	R
GST-XM1	Délétion partielle	+/-	S
HMOX2	c.544G>A	Hétérozygote	R
EPAS1	Promoteur adaptatif	Homozygote	R+

- **R+ = Résistance élevée**
- **R = Résistance modérée**
- **S = Susceptibilité relative**
- **Score global de résistance estimé : 8.9 / 10**



RAPPORT MÉDICAL ET GÉNÉTIQUE COMPLET – SUJET EXPO NX-A

V. INTERPRÉTATION GÉNÉTIQUE

Le sujet présente un profil exceptionnel de résistance partielle au NX-A.

Les variants identifiés suggèrent :

- réduction de la fixation neurotoxique sur certaines jonctions nerveuses,
- maintien partiel de la transmission cholinergique malgré exposition,
- métabolisme lent mais constant des dérivés toxiques,
- meilleure tolérance à l'hypoxie et à l'air dégradé,
- résistance accrue au stress oxydatif pulmonaire.

Ces éléments expliquent sa survie prolongée en milieu contaminé. Toutefois, cette résistance ne constitue pas une immunité.

VI. CONSTATS CLINIQUES ACTUELS

- Toux fréquente, parfois productive.
- Irritation chronique des voies respiratoires.
- Fatigue croissante.
- Amaigrissement progressif.
- Tremblements fins occasionnels.
- Altération générale lente mais visible.

VII. DÉGRADATION ORGANIQUE EN COURS

Le NX-A demeure un gaz neurotoxique destructeur. Chez ce sujet, les effets aigus sont ralentis, mais les lésions cumulatives persistent.

Les examens orientent vers :

- fibrose pulmonaire progressive,
- inflammation bronchique chronique expliquant la toux répétée,
- surcharge hépatique liée à la détoxification continue,
- atteinte rénale progressive par filtration toxique,
- altération neurologique périphérique lente,
- stress oxydatif cellulaire massif,

Le sujet survit au poison, mais le poison continue de consommer ses organes.



RAPPORT MÉDICAL ET GÉNÉTIQUE COMPLET – SUJET EXPO NX-A

VIII. PRONOSTIC

Sans intervention :

- insuffisance respiratoire chronique probable,
- défaillance hépatique ou rénale progressive,
- aggravation neurologique irréversible,
- réduction importante de l'espérance de vie.

Le sujet est vraisemblablement condamné à moyen terme si aucune solution médicale n'est développée.

IX. AXES THÉRAPEUTIQUES PRIORITAIRES

- Imagerie pulmonaire complète.
- Bilan hépatique et rénal rapproché.
- Traitement anti-inflammatoire respiratoire ciblé.
- Mise au point d'un protocole de sevrage progressif du NX-A.
- Support respiratoire assisté si aggravation.
- Isolement biologique contrôlé pour études complémentaires.
- Exploitation potentielle de son sang pour synthèse d'un traitement transitoire.

X. CONCLUSION FINALE

Le sujet représente un cas rare d'adaptation humaine prolongée à un environnement neurotoxique extrême. Son organisme a développé – ou acquis – des mécanismes lui permettant de survivre là où la plupart meurent rapidement. Cependant, cette survie repose sur un équilibre instable. Le NX-A n'a pas cessé d'agir : il le détruit lentement de l'intérieur. Le sujet n'est pas guéri. Il est simplement en sursis.

Note : Ce corps a appris à vivre dans le poison. Il n'a jamais appris à lui échapper.

Gilay
Rosco